REVISE PARA PROVA · SEU RESUMO EM UMA ÚNICA FOLHA

Abdome Agudo

Inflamatório, obstrutivo, vascular e hemorrágico em uma página

MAIS COBRADO

- **1º TG18** na colecistite
- **2º Hinchey** dita a conduta
- **3º Dor desproporcional** = isquemia
- **4º Obstrução**: alta/baixa, parcial/total, necrose?

1 As cinco síndromes

dor > 6 h = cirúrgico até prova em contrário

Síndrome	Pista	Causas
Inflamatória	Dor moderada que piora em horas a dias; vômitos **depois** da dor; febre baixa	Apendicite, colecistite, pancreatite, diverticulite, colangite
Perfurativa	Dor **explosiva**, abdome em tábua, pneumoperitônio	Úlcera péptica, neoplasia gástrica, DII, corpo estranho
Obstrutiva	Cólica + distensão + vômitos + parada de gases e fezes	**Bridas (~75%)**, hérnia, câncer de cólon, volvo
Vascular	Dor **desproporcional** ao exame, FA, lactato alto, sangue nas fezes	Embolia/trombose mesentérica, trombose venosa, NOMI
Hemorrágica	Dor súbita máxima desde o início + choque	Ectópica rota, aneurisma de aorta roto, cisto hemorrágico

Instável: **reanimar antes da TC**. Exame: inspeção → ausculta → percussão → palpação; nunca esquecer hérnias, genitais e toque retal. **β-hCG** em toda mulher fértil; **ECG** em idoso, diabético e dor alta.

2 Inflamatório

APENDICITE

Mais comum (10–30 anos). Dor periumbilical → **FID** em ~24 h, anorexia. **Blumberg**, Rovsing, psoas (retrocecal), obturador (pélvica). Diagnóstico **clínico**; TC é o melhor exame (> 7 mm). Leucócitos > 20.000 = complicada. Videolaparoscopia em dúvida, obesos e mulheres férteis; antibiótico só na não complicada (40–50% recidivam).

COLECISTITE (TG18)

Dor em HD > 6 h + **Murphy**. A local + B sistêmico = suspeita; + C imagem (USG: parede > 4 mm, líquido) = definitiva. **I**: CVL em 24–48 h · **II** (leuco > 18 mil, massa, > 72 h): CVL se equipe experiente, senão drenar · **III** (disfunção orgânica): UTI + **colecistostomia**. Acalculosa: UTI, queimado, NPT.

DIVERTICULITE (HINCHEY)

> 40 anos, dor em **FIE**. TC é o padrão-ouro. **I** abscesso pericólico: conservador · **II** abscesso distante: ATB EV + drenagem se > 4 cm · **III** purulenta e **IV** fecal: cirurgia (Hartmann se instável). **Colonoscopia proibida** na fase aguda; obrigatória após 4–6 semanas.

PANCREATITE AGUDA

Litíase (~40%) e álcool (~30%). Dor em barra, prece maometana. **2 de 3**: clínica, lipase/amilase ≥ 3×, imagem. USG na entrada (causa); **TC só após 48–72 h**. Gravidade: Ranson ≥ 3, Marshall, Atlanta. Ringer guiado por metas, dieta precoce, **sem ATB profilático**, step-up.

3 Obstrutivo

tríade: cólica + distensão + vômitos

Alta: vômitos precoces, pouca distensão, mais desidratação. **Baixa:** vômitos tardios/fecaloides, muita distensão. **Alça fechada** (válvula ileocecal continente) distende o ceco (> 12 cm): risco de ruptura, emergência. Sofrimento de alça: dor vira contínua, febre, leucocitose, peritonite, acidose (nenhum sinal é definitivo).

RX em 3 incidências: **empilhamento de moedas** (delgado), **grão de café** (volvo de sigmoide); TC mostra transição e **redemoinho**. Tratamento: SNG + hidratação + correção eletrolítica (75% das parciais melhoram em 24 h). **Cirurgia**: completa, estrangulamento, alça fechada ou parcial sem melhora em 48 h. Volvo: descompressão por colonoscopia. Toque retal obrigatório.

4 Vascular e hemorrágico

Isquemia mesentérica (mortalidade 60–80% com necrose): **embolia** 40–50% (FA, AMS distal à cólica média) · **trombose** 15–30% (angina mesentérica, medo de comer) · venosa 5–15% (trombofilia, ACO) · NOMI (choque, vasopressor). Mucosa até 6 h; **transmural após 12 h**. Lactato normal no início não exclui. **AngioTC** só no estável. Revascularizar, ressecar o inviável, second-look em 24–48 h.

Hemorrágico: idoso tabagista = **aneurisma de aorta roto** (dor lombar + massa pulsátil + choque; tríade em só 30–50%) · mulher fértil = **ectópica rota**. **Proust** (grito do Douglas), **Laffont** (ombro), Cullen e Grey-Turner. Instável: **POCUS/FAST** e centro cirúrgico. Tríade letal: hipotermia, acidose, coagulopatia; transfusão 1:1:1, **ácido tranexâmico 1 g**, PAS alvo 80.

Não confunda na prova

Os distratores que mais derrubam

1. **Abdome inocente não descarta isquemia:** a marca é dor atroz com exame benigno.
2. **Sangramento vaginal não afasta ectópica:** o β-hCG é sempre obrigatório.
3. **Dor lombar súbita no idoso vasculopata** é aneurisma roto até prova em contrário.
4. **Instável não vai para a TC:** peritonite ou choque refratário vão direto para a cirurgia.
5. **Febre ausente** não exclui apendicite; idoso e imunossuprimido têm exame pobre.
6. **Amilase** não mede gravidade; a lipase é mais específica.
7. **TC precoce** na pancreatite subestima a necrose.
8. **Antibiótico profilático** é contraindicado na pancreatite (só necrose infectada).
9. **Colonoscopia na diverticulite aguda** é proibida; depois, é obrigatória.
10. **Não espere vômito fecaloide** para diagnosticar obstrução baixa.
11. **Bridas** são a causa mais comum de obstrução: pergunte por cirurgias prévias.

Números que caem

Apêndice > **7 mm** · parede da vesícula > **4 mm** · abscesso diverticular > **4 cm** drena
Ceco > **12 cm** · isquemia: mucosa 6 h, transmural **12 h**
Lactato > **2** suspeita · > **4** choque avançado · TG18 III: creatinina > 1,9

Elaborado pela MedSum com base nos resumos de abdome agudo inflamatório, obstrutivo e vascular/hemorrágico do 8º semestre (aulas de Clínica Cirúrgica; Sabiston; Harrison; TG18).